

# 1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La **Ley N.º 16.744** sobre **Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales**, promulgada en 1968, constituye el **pilar jurídico** de la salud ocupacional chilena. Su objetivo es **proteger a los trabajadores frente a daños derivados del trabajo**, otorgando prestaciones médicas, económicas y preventivas.

Esta ley ha permitido establecer un **modelo mixto de gestión**, en el cual participan **mutualidades privadas sin fines de lucro** y el **Instituto de Seguridad Laboral (ISL)**, bajo la supervisión de la **Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)** y el **Ministerio de Salud (MINSAL)**.

En el contexto del **EUNACOM**, conocer la Ley 16.744 es esencial, ya que define las responsabilidades del médico general en la **notificación, derivación, seguimiento y certificación** de enfermedades y accidentes laborales.

---

## 2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

### 2.1. Objetivos de la Ley 16.744

1. **Prevenir** accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
  2. **Otorgar atención médica gratuita** y oportuna a los trabajadores afectados.
  3. **Proveer prestaciones económicas** por incapacidad temporal o permanente.
  4. **Rehabilitar y reinserir** a los trabajadores en el ámbito laboral.
  5. **Fortalecer la fiscalización y vigilancia** de los riesgos laborales.
- 

### 2.2. Población cubierta

- **Trabajadores dependientes del sector público y privado.**

- **Estudiantes en práctica profesional** (DS N.º 313, 1972).
  - **Trabajadores independientes afiliados voluntariamente** (Ley 20.894, 2016).
  - **Funcionarios municipales y de salud primaria.**
- 

## 2.3. Definiciones clave

| Concepto                       | Definición legal según Ley 16.744                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accidente del trabajo</b>   | Lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, y que le produce incapacidad o muerte. |
| <b>Accidente de trayecto</b>   | Acontecido en el traslado directo entre el domicilio y el lugar de trabajo (incluye trayecto inverso).   |
| <b>Enfermedad profesional</b>  | Enfermedad causada directamente por el ejercicio de la profesión o trabajo.                              |
| <b>Prestaciones médicas</b>    | Atención médica integral gratuita (hospitalaria, farmacológica, quirúrgica, rehabilitación).             |
| <b>Prestaciones económicas</b> | Subsidio por incapacidad laboral, pensiones y compensaciones por invalidez o muerte.                     |

---

## 3. Organismos administradores del seguro

La Ley 16.744 define dos grandes tipos de **organismos administradores (OA)**:

### 3.1. Mutualidades de empleadores

Instituciones privadas sin fines de lucro, encargadas de la prevención, atención y compensación de los riesgos laborales.

| <b>Mutualidad</b>                               | <b>Fundada</b> | <b>Cobertura principal</b>      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>ACHS (Asociación Chilena de Seguridad)</b>   | 1958           | Empresas grandes y medianas     |
| <b>IST (Instituto de Seguridad del Trabajo)</b> | 1959           | Puertos, industria y servicios  |
| <b>MUSEG (ex-Mutual de Seguridad CChC)</b>      | 1963           | Construcción, minería, comercio |

#### **Funciones principales:**

- Evaluar riesgos y promover medidas preventivas.
- Entregar atención médica y rehabilitación.
- Otorgar subsidios y pensiones por incapacidad o fallecimiento.
- Capacitar y asesorar en seguridad laboral.

---

### **3.2. Instituto de Seguridad Laboral (ISL)**

Organismo público dependiente del **Ministerio del Trabajo y Previsión Social**, que **administra el seguro para trabajadores del Estado, pymes y empleadores no afiliados a mutualidades.**

#### **Funciones:**

- Administrar el seguro de la Ley 16.744 para el sector público y microempresas.
- Supervisar condiciones laborales junto con las SEREMI de Salud.
- Entregar prestaciones médicas y económicas.

---

### **3.3. Rol de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)**

La **SUSESO** es el **ente fiscalizador** del sistema, encargado de:

- Supervisar el cumplimiento de la Ley 16.744.
  - Resolver controversias sobre origen laboral de las patologías.
  - Emitir circulares y dictámenes interpretativos.
  - Consolidar estadísticas nacionales de accidentabilidad.
- 

### 3.4. Rol del Instituto de Salud Pública (ISP)

El **ISP** apoya técnicamente en:

- Vigilancia de agentes químicos, físicos y biológicos.
  - Control de laboratorios de dosimetría y mediciones ambientales.
  - Programas de vigilancia sanitaria (sílice, plomo, ruido, etc.).
- 

## 4. Prestaciones otorgadas

### 4.1. Prestaciones médicas

- Atención médica, quirúrgica y hospitalaria.
- Rehabilitación física y mental.
- Prótesis, ortesis y ayudas técnicas.
- Medicamentos, insumos y traslados gratuitos.

### 4.2. Prestaciones económicas

| Tipo                              | Descripción                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Subsidio por incapacidad temporal | Pago diario equivalente al 100 % de la remuneración imponible. |

|                                                         |                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indemnización por incapacidad permanente parcial</b> | Pago único si la pérdida de capacidad de ganancia es entre 15 % y 40 %. |
| <b>Pensión de invalidez parcial o total</b>             | Renta mensual vitalicia según grado de incapacidad.                     |
| <b>Pensión de sobrevivencia</b>                         | Para beneficiarios en caso de fallecimiento laboral.                    |

---

## 5. Proceso de calificación de accidentes y enfermedades laborales

| <b>Etapas</b>                          | <b>Descripción</b>                                         | <b>Responsable</b>            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Sospecha</b>                     | Médico tratante identifica posible origen laboral.         | Médico en APS o urgencia.     |
| <b>2. Notificación</b>                 | Envío de formulario de accidente o enfermedad profesional. | Empleador o médico tratante.  |
| <b>3. Evaluación técnica</b>           | Investigación de causalidad y condiciones laborales.       | OA o ISL.                     |
| <b>4. Calificación</b>                 | Determinación de origen: laboral o común.                  | SUSESO (si hay controversia). |
| <b>5. Otorgamiento de prestaciones</b> | Tratamiento, subsidios, rehabilitación.                    | Mutualidad o ISL.             |

---

### **5.1. Documentos y formularios relevantes**

- DIAT (Denuncia Individual de Accidente del Trabajo).
  - DIEP (Denuncia Individual de Enfermedad Profesional).
  - Formulario de notificación médica (FEP).
- 

## **6. Prevención y promoción**

### **6.1. Prevención primaria**

- Evaluación de riesgos laborales (matrices y mapas de riesgo).
- Capacitaciones y comités paritarios.
- Fiscalización sanitaria de la SEREMI.

### **6.2. Prevención secundaria**

- Vigilancia de trabajadores expuestos.
- Exámenes ocupacionales y periódicos.
- Monitoreo de ruido, sílice, plomo, etc.

### **6.3. Prevención terciaria**

- Rehabilitación integral del trabajador afectado.
  - Programas de reinserción laboral y adaptación del puesto.
  - Evaluación de invalidez y compensación económica.
- 

## **7. Rol del médico general**

El médico general cumple funciones esenciales en la aplicación de la Ley 16.744:

| Rol                                                                                                                                               | Ejemplo                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pesquisador</b>                                                                                                                                | Detecta síntomas de posible origen laboral.         |
| <b>Notificador</b>                                                                                                                                | Emite la DIEP o DIAT ante sospecha razonable.       |
| <b>Educador</b>                                                                                                                                   | Orienta a trabajadores sobre derechos y prevención. |
| <b>Coordinador intersectorial</b>                                                                                                                 | Deriva y comunica con mutualidades e ISL.           |
| <b>Asesor técnico</b>                                                                                                                             | Participa en diagnósticos de salud laboral en APS.  |
| En caso de duda sobre el origen laboral, el médico <b>debe notificar igual</b> , ya que la investigación la realiza el OA, no el médico tratante. |                                                     |

## 8. Supervisión y fiscalización

| Institución                  | Función principal                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SUSESO</b>                | Supervisa legalidad y gestiona apelaciones.            |
| <b>MINSAL / SEREMI</b>       | Fiscaliza condiciones sanitarias laborales.            |
| <b>ISP</b>                   | Control técnico y vigilancia de agentes ocupacionales. |
| <b>Dirección del Trabajo</b> | Fiscaliza cumplimiento de normas laborales.            |

## 9. Estadísticas y situación actual en Chile (2024)

- **Tasa de accidentabilidad laboral:** 3,5 % (SUSESO 2023).
- **Tasa de mortalidad laboral:** 4,2 por 100.000 trabajadores.
- **Enfermedades profesionales más frecuentes:** hipoacusia, TME, silicosis, dermatitis de contacto.
- **Cobertura del seguro:** 98 % de los trabajadores formales.

### Tendencia:

Disminución sostenida de accidentes fatales, pero aumento de enfermedades musculoesqueléticas y mentales relacionadas con el estrés laboral.

---

## 10. Errores comunes en EUNACOM

| Error frecuente                                               | Corrección conceptual                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| No notificar un caso sospechoso de origen laboral             | Toda sospecha debe notificarse a la mutualidad o ISL.                  |
| Pensar que solo los trabajadores dependientes están cubiertos | Los independientes pueden afiliarse voluntariamente.                   |
| Confundir prestaciones médicas con previsionales              | Las prestaciones de la Ley 16.744 son <b>integrales y gratuitas</b> .  |
| Creer que la Ley solo cubre accidentes físicos                | Incluye también enfermedades mentales y ergonómicas de origen laboral. |
| Ignorar el rol de la SUSESO                                   | Es la entidad que resuelve disputas sobre calificación del origen.     |

---



## 11. Complicaciones y desafíos actuales

- **Subnotificación persistente** de enfermedades profesionales.
- **Cobertura limitada** en trabajadores informales o independientes.
- **Nuevos riesgos emergentes:** trabajo remoto, estrés digital, nanotecnología.
- **Desigualdad territorial:** menor acceso a mutualidades en regiones extremas.
- **Necesidad de modernizar la Ley 16.744** con enfoque biopsicosocial.

### Pronóstico:

Chile se orienta hacia un **modelo preventivo, inclusivo y digitalizado** de salud ocupacional, integrando telemedicina laboral, vigilancia ambiental y apoyo psicosocial en el lugar de trabajo.

---

## 12. Referencias ministeriales y técnicas

- Ley N.º 16.744 (1968). Diario Oficial de la República de Chile.
  - SUSESO (2023). Informe Anual sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - MINSAL (2024). Programa Nacional de Salud del Trabajador.
  - ISP (2023). Protocolos de Vigilancia de Agentes Ocupacionales.
  - OIT (2022). Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores.
- 

## 13. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. La **Ley 16.744** protege a todos los trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales, garantizando atención médica gratuita y compensación económica.
2. Los **organismos administradores** (mutualidades e ISL) gestionan la prevención, atención y rehabilitación.
3. El **médico general** tiene la obligación legal de **notificar casos sospechosos** y colaborar en la calificación.

4. Las **prestaciones incluyen atención médica, rehabilitación y subsidios o pensiones.**
5. La **SUSESO** supervisa y resuelve controversias, mientras que el **ISP** lidera la vigilancia técnica.
6. Persisten desafíos en cobertura, subnotificación y reconocimiento de riesgos emergentes.
7. La salud ocupacional moderna busca **trabajos seguros, saludables y sostenibles**, en línea con la **Agenda 2030 de la OIT y OMS.**